

Estado de México, 18 de septiembre de 2025 Fecha automática
TA:96/56mmHg ((presión sistólica) + (2 × presión diastólica)] / 3: 161cm Peso: 63.100 IMC
con la formula y si es que tenemos el peso del primer trimestre que salga la ganancia de
peso actual

Doctor a referir o A quien corresponda

Diana Yareli Gonzalez Hernandez

Paciente:

Estudio Solicitado:

Evaluación estructural o morfológica

Edad gestacional:

23.0 Semanas si aquí tenemos la edad
gestacional que daría por el primer trimestre...

**Fecha probable de parto (USG 1er
Trimestre si lo tenemos):**

15 de Enero de 2026

Fecha probable de parto (USG actual)

07 de Enero de 2026

Se realizó estudio ultrasonografico de alta definición, utilizando un equipo General Electric
Volusson Expert con transductor convexo transabdominal, volumétrico de banda ancha,
encontrando:

Impresión diagnóstica:

- Feto único vivo / muerto Frecuencia Cardiaca Fetal si esta vivo xxx latidos / minuto
- Fetometri de XX.xx semanas.
- Peso Fetal Estimado de (XXX +- XX) en percentil XX de Hadlock
- **Exploración estructural: completa o incompleta.. y si es incompleta un espacio para detallar o poner el segmento anatómico**

Crecimiento fetal:

- La fetometría **es acorde a lo estimado por ultrasonido (previo si tenemos nosotros o a ultrasonido de tal fecha que reporta tales semanas) .** Se observa un crecimiento fetal armónico / disarmonico entre segmentos.
- **Exploración estructural:**
La exploración física no muestra alteraciones estructurales aparentes. O muestra tal (espacio blanco para que el médico diga)
- **Tamizaje de cromosomopatías:**
Sin marcadores de cromosomopatía. O Tales **marcadores positivos** (te hago lista) que se iran desplegando en cada sección. Si salen marcadores positivos, debe aparecer una leyenda que diga, por lo que sugerimos un abordaje individualizado.

- **Tamizaje de Parto Pre término**

El tamizaje para parto pre término es te deje un semáforo de riesgo

- **Tamizaje de Preeclampsia:**

El IP medio de Arterias uterinas es 0.7 menor al Percentil 95.

StarMedica Tlalnepantla

Hospital San Angel Inn Satélite

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

- **Líquido y placenta:**

La implantación y características placentarias, así como el líquido amniótico son normales. Te deje una sección específica

Dra. María Nallely Moreno Uribe

Especialista en Ginecología y obstetricia 7605178
Especialista en Medicina Materno Fetal C.P.8631423
Fetal Medicine Foundation No. 105171
Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia :7354
Consejo Mexicano de Medicina Materno Fetal:131

Dra. María Teresa Flores Molina

Especialista en Ginecología y Obstetricia
Especialista en Medicina Materno Fetal 14975747
Fetal Medicine Foundation No.275492
Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia : 13536
Consejo Mexicano de Medicina Materno Fetal: 589

Dra. Sandra Ivonne Pacheco Ruiz

Especialista en Ginecología y Obstetricia 14573228
Especialista en Medicina Materno Fetal C.P.14933179
Fetal Medicine Foundation No.215244
Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia : 14343

Antecedentes clínicos de importancia

- ☐ Edad materna: _____ años
- ☐ IMC: _____ kg/m²
- Presión arterial media
- Ganancia de peso en el embarazo actual
- ☐ Hipertensión crónica / Diabetes / LES / SAF: Sí / No
- ☐ Antecedente de preeclampsia / RCIU: Sí / No
- ☐ Embarazo múltiple: Sí / No
- ☐ Fertilización in vitro o donación ovular: Sí / No
- ☐ Presión arterial media (PAM): _____ mmHg

StarMedica Tlalnepantla

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601

Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

- ☐ Índice de pulsatilidad promedio de arterias uterinas (UtA-PI): _____ (p _____)
- ☐ Presencia de muesca bilateral: Sí / No
- ☐ Morfología placentaria: Normal / Lagunas / Engrosada / Irregular
- Antecedente de Parto Pretérmino (menos de 34 semanas) Sirve para el semaforo de parto pretrmino

Evaluación Anatómica Fetal - Ultrasonido Estructural Segundo Trimestre (ISUOG 2025)

Cráneo y sistema nervioso central

El cráneo presenta una osificación homogénea y una morfología regular, sin deformidades. En el plano axial transventricular se identifican adecuadamente las estructuras del **complejo anterior**: fisura interhemisférica, surco calloso, genu del cuerpo calloso, cavum septi pellucidi (CSP) y cuernos anteriores de los ventrículos laterales. El CSP presenta morfología rectangular con base anterior y relación longitud/ancho conservada (> 1.5). Los cuernos anteriores muestran disposición normal en "coma" convergente hacia la línea media, sin evidencia de paralelismo ni deformidad. No se observan desviaciones de la línea media ni alteraciones en la morfología ventricular.

En los planos coronales y axiales posteriores se visualiza el **complejo posterior** conformado por el esplenio del cuerpo calloso, el surco calloso posterior, la fisura parieto-occipital y las paredes mediales de los ventrículos laterales. La fisura interhemisférica posterior se observa de grosor normal y simétrica; el cuerpo calloso muestra continuidad aparente en su trayecto dorsal, y no se evidencia ensanchamiento ventricular ni alteración de la pared medial. Configuración ecográfica compatible con desarrollo normal del eje medio posterior. El diámetro de los ventriculos posteriores es XX para el derecho y XX para el izquierdo

En el plano axial transcerebeloso se visualiza adecuadamente la **fosa posterior**, con hemisferios cerebelosos simétricos, bien delimitados y ecogenicidad homogénea. El **vermis cerebeloso** se observa completo y con morfología normal, cubriendo el cuarto ventrículo. El **diámetro transcerebeloso (TC)** de XX.x milímetros concordantes xon XX. XX semanas de gestacion. La **cisterna magna** se identifica como un espacio anecoico regular con medida de (XX mm) e **2 y 10 mm**, sin evidencias de dilatación o compresión. No se observa desplazamiento del cerebelo ni alteraciones en la línea media. El pliegue nuchal es de XX mm (lo normal es menor de 6 mm)

Cara y cuello

El perfil facial muestra una frente convexa, hueso nasal presente y de longitud normal, maxila y mandíbula bien alineadas. El labio superior se observa continuo sin evidencia de hendidura, y las órbitas aparecen simétricas con lentes visibles.

StarMedica Tlalnepantla

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601

Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

Corazon

El tórax es de morfología ovalada con pulmones hipoeoicos simétricos. El corazón ocupa cerca del 30–35 % del área torácica, con eje de $45^\circ \pm 20^\circ$ dirigido a la izquierda y un índice cardiotorácico (ICT) ~ 0.5 . El plano de cuatro cámaras revela cavidades simétricas, tabique interventricular continuo y válvulas atrioventriculares alineadas. Los tractos de salida izquierdo y derecho cruzan correctamente, y en la vista de tres vasos y tráquea se observa la secuencia pulmonar–aorta–vena cava superior con trayecto ductal normal.

Tórax y diafragma

La pared torácica es íntegra y el diafragma se observa como una línea ecogénica hipercurva que separa adecuadamente el tórax del abdomen. No hay masas intratorácicas ni herniación abdominal.

Abdomen y pared abdominal

El abdomen tiene contorno circular y ecogenicidad uniforme. En el corte abdominal estándar se visualiza el estómago en cuadrante superior izquierdo, la vena umbilical intrahepática y la vesícula biliar; la pared abdominal se encuentra cerrada en la inserción del cordón. Se observan dos arterias umbilicales. No hay visceromegalias ni ascitis.

Sistema genitourinario

La vejiga fetal se observa central, con vaciamiento normal durante la exploración. Los riñones son visibles bilateralmente con ecogenicidad cortical homogénea y pelvis no

Columna vertebral

En planos sagital, coronal y transversal se aprecia la alineación completa del raquis desde la región cervical hasta el sacro. Los tres centros de osificación son visibles en cada vértebra y la piel dorsal es continua. No se detectan disrafismos ni desviaciones.

Extremidades y esqueleto

Se visualizan las cuatro extremidades con adecuada implantación y movilidad. Los huesos largos (húmero, radio, cúbito, fémur, tibia, peroné) muestran longitud y ecogenicidad normales para la edad gestacional. Las manos se observan abiertas con pulgares diferenciados y los pies correctamente alineados.

Placenta, cordón umbilical y líquido amniótico

La placenta se observa con implantación (anterior / posterior / fúndica / lateral derecho o izquierda), de forma discoide, bordes regulares y espesor acorde a la edad gestacional (promedio 20–40 mm). Presenta una ecotextura homogénea, correspondiente a Grado 0 de maduración placentaria. La distancia del borde inferior al orificio cervical interno es de

StarMedica Tlalnepantla

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601



Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

(XX mm) y si es menor de 10 mm debe clasificarse como placenta baja y salir en la primera hoja si es así debe salir una leyenda que diga, se sugiere control ecografico entre las 32 y 34 semanas (y que salga la fecha) y valoracion con doppler dirigido
La placenta se encuentra adecuadamente implantada, con grosor acorde a la edad gestacional y sin lagunas anormales. El cordón umbilical contiene tres vasos y se inserta central o paracentral. El líquido amniótico es normal en cantidad y aspecto. Con un bolsillo maximo de (XX mm)

 FIGO 0 — Placenta normal

Zona retroplacentaria íntegra, sin lagunas.
Riesgo: Bajo.

 FIGO 1 — Acretismo parcial

Lagunas aisladas, miometrio adelgazado.
Riesgo: Leve.

 FIGO 2 — Invasión miometrial

Lagunas múltiples, pérdida de la zona retroplacentaria, vasos puente.
Riesgo: Moderado.

 FIGO 3 — Percretismo / invasión vesical

Disrupción completa del miometrio, protrusión placentaria, flujo turbulento extenso.
Riesgo: Alto.

Evaluación ecográfica y antecedentes

- ☐ Antecedente de parto pretérmino (<34 sem): Sí / No / Desconocido
- ☐ Longitud cervical (LC): _____ mm
- ☐ Índice de consistencia cervical (CCI): _____ %
- ☐ Funneling: Sí / No (longitud del cono: _____ mm)
- ☐ Sludge intraamniótico: Sí / No / Dudoso

Semáforo de riesgo Prenacer – Parto Pretérmino

Color / Categoría	Criterios principales	Descripción / Implicación	Riesgo estimado
 Bajo riesgo	Sin antecedente de PP	Condiciones cervicales normales.	<1 %

StarMedica Tlalnepantla

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601



Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

	LC $\geq$ 30 mm y CCI $\geq$ 65 % Sin funneling ni sludge	Seguimiento habitual.	
● Riesgo intermedio	Antecedente único de PP tardío (34–36 sem) o pérdida tardía LC 25–29 mm o CCI 50–64 % Funneling leve (<5 mm) sin sludge	Riesgo moderado, considerar vigilancia cada 2–3 semanas.	≈10–15 %
● Riesgo alto	$\geq$ 1 antecedente de PP <34 sem o $\geq$ 2 partos pretérmino LC <25 mm o CCI <50 % Funneling $\geq$ 5 mm o sludge leve/moderado	Requiere seguimiento semanal y considerar progesterona / cerclaje según historia.	≈20–40 %
● Riesgo muy alto	Antecedente de PP <32 sem + LC <25 mm o CCI <50 % Sludge marcado con debris ecogénico evidente $\pm$ funneling	Probabilidad elevada de infección/inflamación intraamniótica (FIRS) y parto muy temprano. Manejo intensivo.	>50 %

Interpretación clínica

El riesgo se interpreta considerando primero el antecedente obstétrico y luego los hallazgos cervicales. Si existe antecedente de parto pretérmino temprano y hallazgos de cuello corto o blando, la paciente se clasifica automáticamente como alto o muy alto riesgo. Si no hay antecedentes, el riesgo se ajusta según LC, CCI, funneling y sludge. Recomendaciones: iniciar progesterona vaginal si LC <25 mm o CCI <50 %, valorar cerclaje en antecedente de PP <34 sem con LC <25 mm antes de 24 sem, y control ecográfico semanal o quincenal según categoría

Color / Categoría	Criterios principales (2º trimestre)	Interpretación / Implicación clínica	Riesgo estimado PE temprana (<34 sem)
● Bajo riesgo	Sin factores clínicos mayores.	Seguimiento obstétrico habitual.	<1 %

StarMedica Tlalnepantla

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601



Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

● Riesgo intermedio	UtA-PI < p90. PAM < 90 mmHg. Placenta normal. 1 factor clínico mayor o UtA-PI entre p90-95 o PAM 90-95 mmHg.	Control Doppler cada 4 semanas.	5-10 %
● Riesgo alto	≥2 factores clínicos mayores, o UtA-PI ≥ p95, o PAM ≥95 mmHg con muesca bilateral.	Disfunción placentaria incipiente; iniciar AAS si <16 sem.	15-30 %
● Riesgo muy alto	Antecedente de PE temprana + UtA-PI ≥ p95 + PAM ≥95 mmHg ± alteración placentaria.	Alta probabilidad de PE/RCIU precoz; control cada 2 semanas.	>40 %

Marcadores Ultrasonográficos - Evaluación Morfológica Segundo Trimestre (ISUOG 2025)

Paciente: _____ EG: _____ sem + _____ días
Fecha: _____ Operador: _____

Cabeza y cerebro

- ☐ Ventriculomegalia leve (> 10 mm)
- ☐ Quistes de plexos coroideos
- ☐ Cisterna magna aumentada (> 10 mm)
- ☐ Dilatación o ausencia del cavum septi pellucidi
- ☐ Agenesia o disgenesia del cuerpo calloso
- ☐ Forma craneal anómala (braqui/dolicocéfala)

Cara y cuello

- ☐ Hueso nasal ausente o hipoplásico
- ☐ Ángulo frontomaxilar aumentado / perfil plano
- ☐ Pliegue nuchal aumentado (> 6 mm)
- ☐ Micrognatia o retrognatia
- ☐ Hendidura labial / palatina

StarMedica Tlalneptantla

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalneptantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601



Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

- ☐ Edema facial o cuello corto

Corazón y mediastino

- ☐ Foco ecogénico intracardiaco
- ☐ Regurgitación tricuspídea
- ☐ Ductus venoso con onda A reversa o ausente
- ☐ Eje cardíaco desviado ($> 65^\circ$ / $< 25^\circ$)
- ☐ Cardiomegalia (ICT > 0.5)
- ☐ Situs anómalo o dextroposición

Tórax y diafragma

- ☐ Hernia diafragmática
- ☐ Pulmones hiperecogénicos
- ☐ Desplazamiento mediastínico

Abdomen y pared abdominal

- ☐ Intestino hiperecogénico
- ☐ Pieloectasia leve (4–7 mm)
- ☐ Cordón umbilical con dos vasos (AUU)
- ☐ Onfalocele / gastrosquisis
- ☐ Vesícula biliar ausente
- ☐ Dilatación intestinal

Extremidades y esqueleto

- ☐ Fémur corto ($< p5$)
- ☐ Húmero corto
- ☐ Clinodactilia / incurvación del quinto dedo
- ☐ Polidactilia / sindactilia
- ☐ "Sandal gap" (separación primer–segundo orjejo)
- ☐ Movimientos fetales restringidos

Sistema genitourinario

- ☐ Megavejiga (> 10 mm)
- ☐ Pelvis renal dilatada (> 7 mm)
- ☐ Riñón único o quistes renales
- ☐ Ambigüedad genital

Placenta, cordón y líquido amniótico

- ☐ Inserción velamentosa del cordón

StarMedica Tlalnepantla

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601



Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

- ☐ Quistes del cordón umbilical
- ☐ Placenta lagunada / engrosada
- ☐ Oligo / polihidramnios

Interpretación global automática del riesgo

- Bajo riesgo: sin marcadores o un marcador aislado menor sin alteraciones estructurales.
- Riesgo intermedio: presencia de un marcador mayor aislado (p. ej. pliegue nucal > 6 mm, hueso nasal ausente) o dos marcadores menores.
- Riesgo alto: presencia de dos o más marcadores mayores, o marcador mayor acompañado de anomalía estructural significativa (cardiopatía, onfalocele, displasia ósea, etc.).

Miomas Visibles No visibles Clasificación FIGO de los Leiomiomas Uterinos (2021-2023)

Tipo FIGO	Localización anatómica	Descripción
0	Submucoso pediculado	Completamente intracavitario, unido al endometrio por un pedículo fino.
1	Submucoso con componente intramural <50%	Más del 50% del volumen protruye hacia la cavidad endometrial.
2	Submucoso con componente intramural ≥50%	Menos del 50% del volumen se proyecta dentro de la cavidad endometrial.
3	Intramural en contacto con el endometrio, sin distorsionar la cavidad	Lesión completamente intramural, pero adyacente al endometrio.
4	Intramural puro	Lesión completamente dentro del miometrio, sin contacto con endometrio ni serosa.
5	Subseroso con componente intramural ≥50%	Mayor parte del volumen dentro del miometrio, protruyendo hacia la serosa.
6	Subseroso con componente intramural <50%	Predomina el componente subseroso, con mínima extensión intramural.

StarMedica Tlalnepantla



Hospital San Ángel Inn Satélite

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

7	Subseroso pediculado	Completamente extracavitario, unido a la serosa uterina mediante un pedículo.
8	Otros (parasitarios, cervicales, retroperitoneales, ligamento ancho)	Sin relación directa con la cavidad endometrial ni la serosa del cuerpo uterino.
Híbrido (2 números)	Miomas que afectan simultáneamente endometrio y serosa	Se describen con dos números que representan la extensión hacia ambas superficies (p. ej., tipo 2–5).

Bibliografía

1. Munro MG, et al. FIGO Classification System (2021 update): Leiomyoma subclassification. Int J Gynaecol Obstet. 2022.
2. ISUOG Practice Guidelines. Ultrasound assessment of uterine leiomyomas. 2023.
3. Dueholm M, et al. UOG. 2021 – Imaging-based classification of fibroids.
4. Donnez J, Dolmans MM. N Engl J Med. 2016 – Uterine fibroids and reproductive outcomes.

Registro ecográfico Prenacer de miomas identificados

# Mioma	Tipo FIGO	Localización uterina	Dimensiones (mm)	Relación con cavidad / serosa	Vascularización (Doppler)	Observaciones clínicas
1	_____	_____	_____ × _____ × _____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____ × _____ × _____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____ × _____ × _____	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____ × _____ × _____	_____	_____	_____

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ceresfertilidad.com%2Fimpacto-de-los-miomas-en-la-fertilidad-humana%2F&psig=AOvVaw1CS0goRHEujJyGU_m5YZd&ust=1760657625336000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBIQjRxqFwoTCJinvfSup5ADFQAAAAAdAAAAABAE

StarMedica Tlalnepantla

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601



Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

Morfología uterina

Clasificación ESHRE–ESGE de malformaciones müllerianas (2021–2023)

Clasificación	Tipo específico / Subtipo	Descripción ecográfica resumida
☐ U0 – Útero normal	—	Cavidad y contorno uterino normales.
☐ U1 – Útero dismórfico	U1a (T-shaped) / U1b (infantil)	Cavidad estrecha o en forma de T o Y, fondo convexo.
☐ U2 – Útero septado	U2a (septum parcial) / U2b (completo)	Fondo uterino externo normal, con tabique interno visible.
☐ U3 – Útero bicorne	U3a (parcial) / U3b (completo)	Fondo uterino hendido, cavidades separadas >50% del espesor miometrial.
☐ U4 – Útero hemiútero (unicornuado)	U4a (cuerno rudimentario funcional) / U4b (no funcional)	Cavidad única lateral, con o sin cuerno rudimentario.
☐ U5 – Útero aplásico o agénésico	—	Ausencia parcial o total de cuerpo y/o cérvix uterino.
☐ U6 – No clasificable / Combinado	—	Alteraciones mixtas o atípicas no incluidas en categorías previas.

INDICES DE CRECIMIENTO

CI (BPD/OFD)	83%	(70-86%)
FL/AC	23%	(20-24%)
FL/BPD	73%	(EG:OOR
FL/HC Hadlock	0.21	(0.16-0.21).
HC/AC Campbell	1.12	(1.06-1.25)

StarMedica Tlalnepantla

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601



Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

Nota de Responsabilidad Médico-Legal

El presente estudio corresponde a una **evaluación anatómica fetal de segundo trimestre**, realizada mediante ultrasonido obstétrico de alta resolución siguiendo los lineamientos internacionales de la **International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG, revisión 2025)** y la **Fetal Medicine Foundation (FMF)**, que establecen el protocolo estandarizado de **20 + 2 planos** para la exploración morfológica fetal.

Este examen tiene como objetivo **evaluar la anatomía fetal visible al momento del estudio**, identificando malformaciones mayores, marcadores ecográficos de cromosomopatía y alteraciones del crecimiento o del ambiente intrauterino.

Sin embargo, **como toda exploración ultrasonográfica, presenta limitaciones inherentes a la técnica y a la edad gestacional**, incluyendo factores maternos (índice de masa corporal elevado, cicatrices o interposición intestinal), fetales (posición desfavorable, movimientos limitados, edad gestacional temprana o avanzada) y técnicos (resolución de imagen o condiciones del equipo).

Debe considerarse que **un estudio estructural normal no excluye de manera absoluta la posibilidad de anomalías genéticas, funcionales o metabólicas**, ya que existen alteraciones que pueden manifestarse en etapas posteriores del embarazo o después del nacimiento. La sensibilidad global reportada para la detección de malformaciones mayores oscila entre **60 % y 85 %**, dependiendo del tipo de defecto, la edad gestacional y la experiencia del operador.

Este estudio ecográfico tiene como objetivo contribuir al **tamizaje de preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) y parto pretérmino** mediante la evaluación anatómica fetal, el Doppler uterino y la valoración cervical.

Su alcance se limita a **identificar factores de riesgo y alteraciones funcionales placentarias o cervicales en el momento del estudio**, sin constituir un diagnóstico definitivo ni predecir con certeza la evolución del embarazo.

La interpretación de este estudio se realiza de acuerdo con los estándares descritos en la literatura médica actual, incluyendo *ISUOG Practice Guidelines: Performance of the routine mid-trimester fetal ultrasound scan* (UOG 2023) y *How to apply the 20 + 2-planes method* (UOG 2025).

El resultado debe integrarse siempre con la **historia clínica, los estudios de tamizaje bioquímico o genético, y la evolución obstétrica individual**.

StarMedica Tlalnepantla

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601



Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630